

# Évaluation de la réponse pathologique après chimiothérapie néoadjuvante associée à une thérapie ciblée dans le cancer du sein précoce HER2-positif

R. NASRI <sup>1,2</sup>, A. LADJEROUD <sup>3</sup>, D. HANNACHI <sup>1</sup>, S. DAOUDI <sup>1</sup>

1. Département de Biologie et Écologie, Faculté des Sciences, Université Yahia Fares, Médéa, Algérie.
2. Laboratoire de Biotechnologie et Valorisation des Ressources Biologiques, Faculté des Sciences, Université Yahia Fares, Médéa, Algérie.
3. Service d'Oncologie Médicale, Centre Pierre et Marie Curie, Alger, Algérie.

## Introduction

En Algérie, le cancer du sein est la première cause de cancer, avec 14 601 nouveaux cas (22,6% des cancers pour les deux sexes). Chez la femme, il représente 41,3% des cancers (14 601 nouveaux cas). Il constitue également la première cause de décès par cancer dans le pays, avec 4 893 décès (13,7% des cancers pour les deux sexes confondus). L'hétérogénéité du cancer du sein est aujourd'hui largement documentée, avec l'existence de multiples sous-types histologiques et moléculaires. Dans environ 20 à 25% des cas, la tumeur surexprime HER2, une caractéristique associée à un pronostic défavorable marqué par des récives précoces et des métastases à distance.

## Matériel et méthodes

- Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 74 patientes traitées pour un cancer du sein précoce HER2-positif entre 2020 et 2025 au service d'oncologie médicale de CPMC d'Alger.
- Les patientes HER2 positives, ont été réparties en deux groupes selon leur statut des récepteurs hormonaux : un groupe RH+/HER2+ (RE+ et/ou RP+, HER2+) et un groupe RH-/HER2+ (RE- et RP-, HER2+).
- 21 patientes ont été assignés au groupe de chimiothérapie combinée avec trastuzumab et pertuzumab (double blocage), et 53 patientes au groupe de chimiothérapie combinée avec trastuzumab seul (blocage simple).
- L'évaluation de la réponse au traitement a été faite sur le sein et sur les ganglions lymphatiques par une étude macroscopique et microscopique.

## Résultats

### 1. Caractéristiques cliniques de la population

- Les caractéristiques cliniques de la population sont résumées dans le tableau 1. Parmi les 74 patientes, 53 (71,62%) appartenaient au sous-type RH+/HER2+ et 21 (28,38%) au sous-type RH-/HER2+.

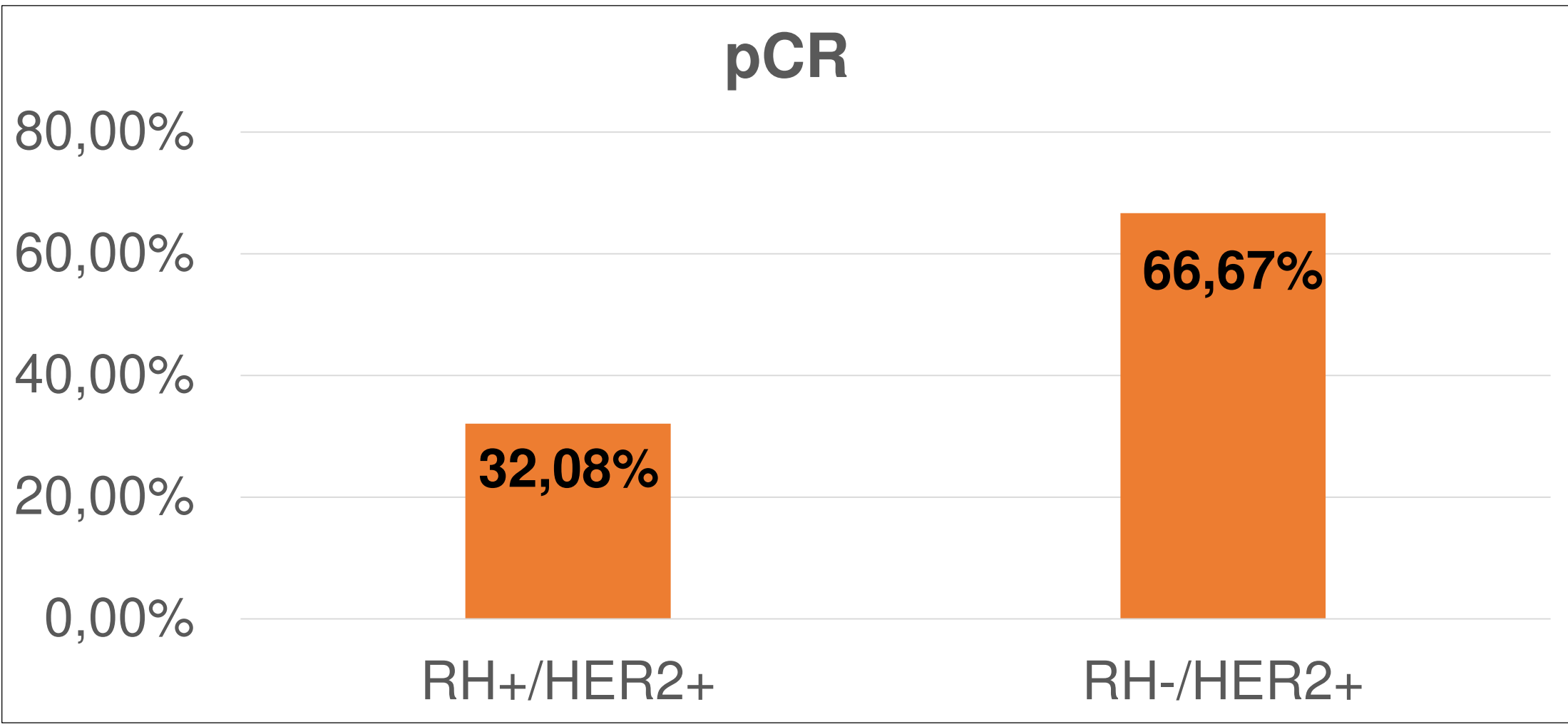
### 2. Caractéristiques histologiques de la population

- Les caractéristiques histologiques de la population sont résumées dans le tableau 2.

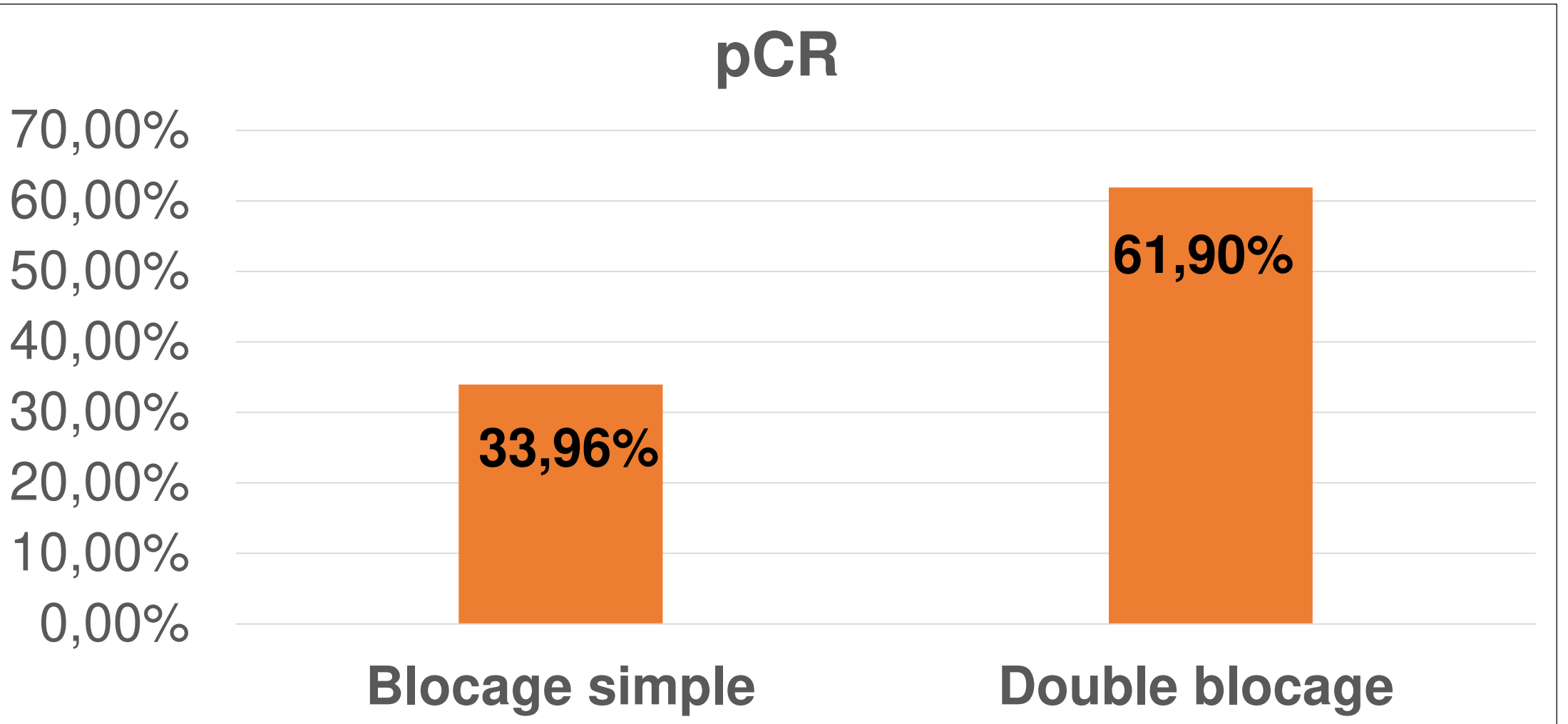
- Dans le groupe RH+/HER2+, le taux de pCR était de 32,08%, contre 66,67% dans le groupe RH-/HER2+, et les résultats ont montré que le groupe RH-/HER2+ présente un taux de pCR plus important que celui du groupe RH+/HER2+ (Figure 2)

| Facteurs cliniques                        | Toutes les patientes (n=74) (%) |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Age au diagnostic (ans)                   |                                 |
| Moyenne ± SD                              | 50,27 ± 11,24                   |
| Médiane                                   | 50                              |
| Extrêmes                                  | 27-77                           |
| < 50 ans                                  | 36 (48,65%)                     |
| ≥ 50 ans                                  | 38 (51,35%)                     |
| Ménopause                                 |                                 |
| Oui                                       | 33 (44,6%)                      |
| Non                                       | 41 (55,4%)                      |
| Parité                                    |                                 |
| Oui                                       | 63 (85,14%)                     |
| Non                                       | 11 (14,86%)                     |
| Antécédents familiaux (sein et/ou ovaire) |                                 |
| Présent                                   | 20 (27,03%)                     |
| Absent                                    | 54 (72,97%)                     |
| Taille de la tumeur                       |                                 |
| Moyenne ± SD                              | 3,62 ± 1,71                     |
| Médiane                                   | 3,1                             |
| Extrêmes                                  | 0,5-8                           |
| < 3 cm                                    | 25 (33,78%)                     |
| ≥ 3 cm                                    | 49 (66,22%)                     |
| Stade T clinique                          |                                 |
| T1                                        | 11 (14,87%)                     |
| T2                                        | 33 (44,59%)                     |
| T3                                        | 06 (8,11%)                      |
| T4                                        | 24 (32,43%)                     |
| Statut ganglionnaire clinique             |                                 |
| Négatif                                   | 13 (17,57%)                     |
| Positif                                   | 61 (82,43%)                     |
| Stade TNM                                 |                                 |
| I                                         | 1 (1,35%)                       |
| II                                        | 40 (54,05%)                     |
| III                                       | 33 (44,6%)                      |
| Sein atteint                              |                                 |
| Sein droit                                | 33 (44,6%)                      |
| Sein gauche                               | 41 (55,4%)                      |

| Facteurs histologiques          | Toutes les patientes (n=74) (%) |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Types histologiques             |                                 |
| CCI                             | 60 (81,08%)                     |
| Carcinomes mixtes               | 05 (6,76%)                      |
| Autres types de carcinome       | 09 (12,16%)                     |
| Grade SBR                       |                                 |
| I-II                            | 56 (75,68%)                     |
| III                             | 18 (24,32%)                     |
| Indice de prolifération (Ki-67) |                                 |
| Moyenne ± SD                    | 43,75 ± 18,41                   |
| Médiane                         | 40                              |
| Extrêmes                        | 10-85                           |
| < 40%                           | 32 (43,24%)                     |
| ≥ 40%                           | 42 (56,76%)                     |

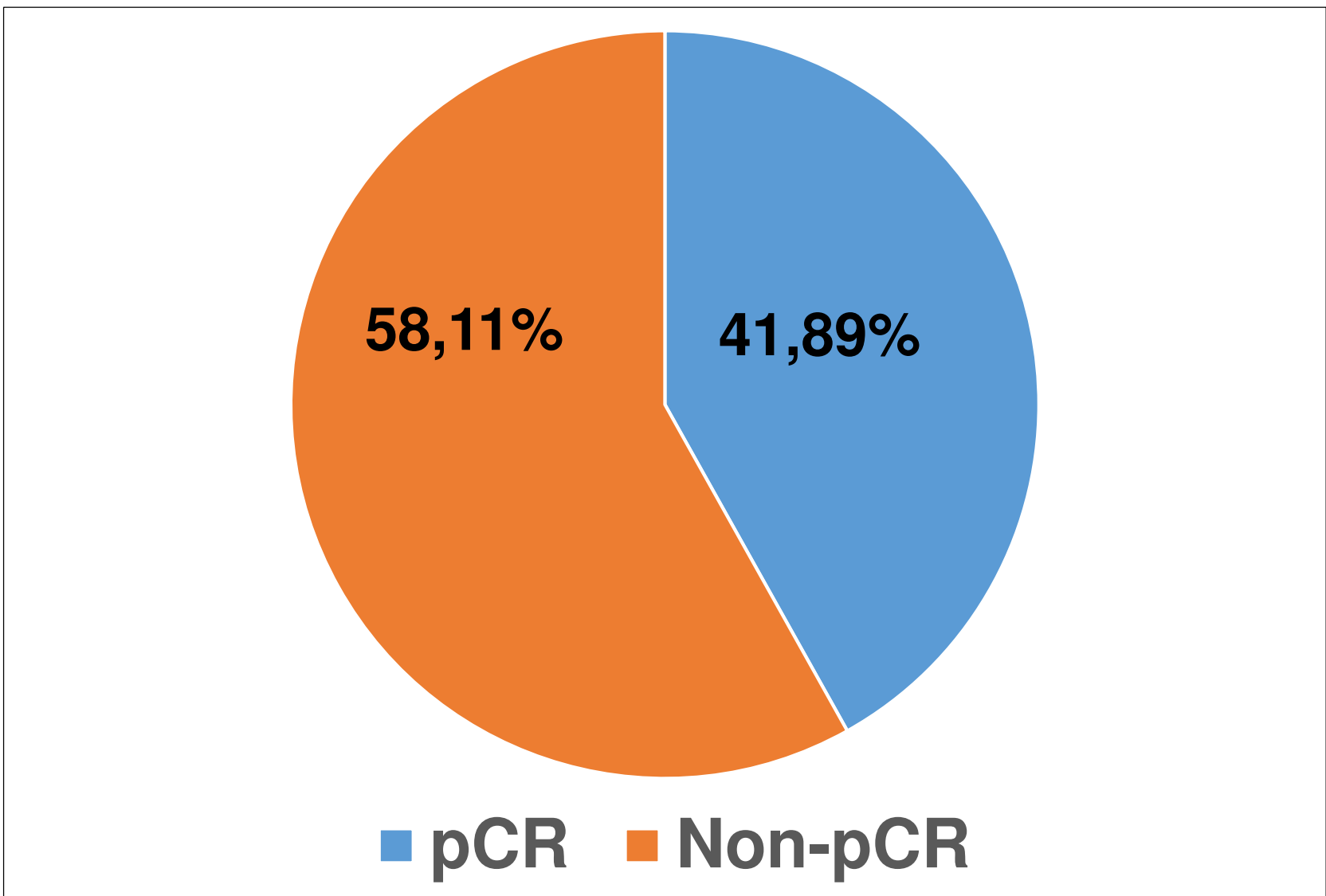


- Dans le groupe blocage simple, le taux de pCR était de 33,96%, contre 61,90% dans le groupe double blocage, et les résultats ont montré que le groupe double blocage présente un taux de pCR plus important que celui du groupe blocage simple (Figure 3)



### 3. Réponse pathologique

- L'effet du traitement et l'appréciation de degré de réponse pathologique ont été évalué par l'analyse microscopique.
- Dans notre population, le taux de réponse pathologique complète (ypT0/is ypN0) était de 41,89% (Figure 1)



## Conclusion

L'association du double blocage par trastuzumab et pertuzumab à la chimiothérapie néoadjuvante a démontré son efficacité dans la prise en charge des cancers du sein HER2-positifs. Cette stratégie de double ciblage permet d'obtenir des taux de pCR supérieurs à ceux observés avec un blocage simple, améliorant ainsi le pronostic des patientes, en particulier celles présentant une tumeur RH-/HER2+.